TOME 08 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Hématologie

Société Française d'Hématologie (SFH) • 343 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 08 : Hématologie.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 343 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Société Française d'Hématologie (SFH).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	343 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 08

Société Française d'Hématologie (SFH) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 08 • Hématologie (343 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

- Chapitre 01 : Introduction à l'hématologie
- Chapitre 02 : Fiches hématologies
- Chapitre 03 : Syndrome hémorragique d'origine hématologique (216)
- Chapitre 04 : Hémogramme (212)
- Chapitre 05 : Anémie (213)
- Chapitre 06 : Thrombopénie (214)
- Chapitre 07 : Éosinophilie (218)
- Chapitre 08 : Syndrome mononucléosique (217)
- Chapitre 09 : Produits sanguins labiles (PSL) (329)

PARTIE 1 — HÉMOPATHIES

- Chapitre 10 : Leucémie aiguë (315)
- Chapitre 11 : Syndrome myélodysplasique (316)
- Chapitre 12 : Syndrome myéloprolifératif (317)
- Chapitre 13 : LLC (leucémie lymphoïde chronique) (318)
- Chapitre 14 : Lymphomes malins (319)
- Chapitre 15 : Myélome multiple (320)

- Chapitre 01 — Introduction à l'hématologie
- Définitions : sang, plasma, sérum
- • Sang = suspension cellulaire dans le plasma
- • Plasma = liquide complexe constitue■ d'eau, de sels mine■raux et de mole■cules organiques
- • Sérum = plasma après coagulation (dépourvu de fibrinogène)
- Localisation de l'hématopoïèse au cours de la vie
- – Sang apparai■t chez l'homme de■s le 21e jour de l'embryogene■se, en me■me temps que les premiers vaisseaux : il est produit dans l'AGM (aorte-gonades-me■sone■phros) et le sac vitellin origine me■sodermique
- – Entre le 2e et le 7e mois de la vie, le foie et la rate prennent la rele■ve
- – Dans les 2 derniers mois de la vie intra-ute■rine la moelle osseuse devient le site pre■dominant de la formation du sang
- – Apre■s la naissance, la moelle est le site exclusif de production sanguine
- – Progressivement, au cours de l'enfance, le tissu he■matopoi■e■tique des os longs est remplace■ par du tissu adipeux

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Introduction à l'hématologie
Chapitre 02 : Fiches hématologies
Chapitre 03 : Syndrome hémorragique d'origine hématologique (216)
Chapitre 04 : Hémogramme (212)
Chapitre 05 : Anémie (213)
Chapitre 06 : Thrombopénie (214)
Chapitre 07 : Éosinophilie (218)
Chapitre 08 : Syndrome mononucléosique (217)
Chapitre 09 : Produits sanguins labiles (PSL) (329)

PARTIE 1 — HÉMOPATHIES

Chapitre 10 : Leucémie aiguë (315)
Chapitre 11 : Syndrome myélodysplasique (316)
Chapitre 12 : Syndrome myéloprolifératif (317)
Chapitre 13 : LLC (leucémie lymphoïde chronique) (318)
Chapitre 14 : Lymphomes malins (319)
Chapitre 15 : Myélome multiple (320)

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Hématologie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Déroulement	1. CFU-GEMM (colony-forming unit granulocyte-erythroid-megakaryocyte-monocyte) 2. Progéniteurs érythroïdes sont successivement : BFU-E (burst-forming unit erythroid) et la CFU-E (colony-forming unit erythroid) 3. Précurseurs sont successivement le pro-érythroblaste et les érythroblastes basophiles (I et II), polychromatophiles et acidophiles -> caractère acidophile (orangé) du cytoplasme traduit la fabrication d'hémoglobine 4. Après énucléation, ce dernier type d'érythroblaste devient un réticulocyte (hématie jeune riche en ARN) -> cette cascade érythroïde permet la production de 16 réticulocytes à partir d'un pro-érythroblaste
Cytologie	Comme dans toutes lignées, chaque division s'accompagne de : -> diminution de taille de la cellule, diminution du rapport nucléocytoplasmique, condensation de la chromatine
Passage dans le sang	Réticulocytes correspondent au cytoplasme des érythroblastes acidophiles après expulsion du noyau : ils demeurent dans la moelle osseuse 1 à 3 jours et 1 à 2 jours dans le sang, comme ils contiennent encore un peu d'ARN, ils peuvent être identifiés et comptés spécifiquement (coloration spéciale ou cytomètre en flux), leur nombre permet d'apprécier la production médullaire en globules rouges (N : 20–100 G/L) Avant de devenir des GR, les réticulocytes perdent leurs mitochondries, ribosomes, et ARN résiduels Quelques hématies sortant de la moelle peuvent contenir un reliquat nucléaire (corps de Howell-Jolly) ou des grains de fer, on ne les observe pas à l'état normal car elles sont éliminées en quelques minutes par les macrophages spléniques lors de leur passage dans la rate
Durée	Érythropoïèse normale dure 7 jours : cette durée peut être diminuée en cas de besoins augmentés, cela a plusieurs conséquences pratiques (ex. après une hémorragie, la moelle osseuse ne peut délivrer de nouvelles hématies qu'après un délai ≥ 3 jours)
Éléments nécessaires	- EPO ++ : principalement synthétisée par les cellules endothéliales péritubulaires du rein en réponse à une hypoxie tissulaire - Vitamines B9 et B12 : indispensables pour la synthèse d'ADN (également dans les autres lignées), une carence diminuant le nombre de mitoses induit une anémie macrocytaire qui peut être associée à une thrombopénie et/ou une leucopénie (pancytopénie) - Fer : nécessaire, mais exclusivement pour l'érythropoïèse (synthèse de l'hème), carence martiale touche seulement cette lignée - Vitamine B6 : nécessaire pour la synthèse de l'hème, mais ses besoins sont très limités

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Hématologie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Durée de vie	120 jours
Forme	Disque biconcave, diame■tre de 7 µm et une e■paisseur de 1,7 µm
Noyau Cytoplasme	- Pas de noyau (cellule anuclée) - Cytoplasme contient : hémoglobine +++ (représent 95% du poids sec), enzymes, glucose, ions (essentiellement K+)
Membrane	Permet au GR de se de■former pour traverser les plus petits capillaires (5 µm de diame■tre) et de reprendre sa forme : - Membrane est compose■e d'une bicouche lipidique de phospholipides stabilise■e par du choleste■rol - A■ l'exte■rieur : couche riche en mucopolysaccharides contenant notamment les substances de groupes sanguins - Prote■ines peuvent e■tre superficielles et mobiles dans la bicouche lipidique, transmembranaires ou sous-membranaires -> Spectrine qui s'organise en tétramères reliés entre eux par l'Actine et la Protéine “bande 4.1” -> Ankyrine : relie la spectrine à l'extrémité cytoplasmique de la protéine transmembranaire “bande 3”
Anomalie	Anomalies des protéines membranaires et des lipides peuvent modifier la forme et diminuer la déformabilité de l'hématie, induisant leur destruction prématurée (hémolyse), ex. sphérocytose héréditaire ou maladie de Minkowski-Chauffard

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 08

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 08 • Hématologie (343 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Société Française d'Hématologie (SFH)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (343 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.